Algoritmo CIF — Cervical

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Cervical. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 3 si «SÍ»

3b ¿Rasgos neuropáticos, déficit de conducción o ninguno? Pueden coexistir; si el inicio fue traumático, el paso 2 ya añade el latigazo.

- DOLOR RADICULAR → 12 Dolor Radicular Cervical
- RADICULOPATÍA → 3 Radiculopatía Cervical
- AMBOS → 12 Dolor Radicular Cervical + 3 Radiculopatía Cervical
- AURA MIGRAÑOSA → sin hipótesis
- FALLA LA MÉDULA → 8 Mielopatía Espondilótica Cervical

SÍ

1 ¿Existen signos de compromiso medular (mielopatía)?

Respuestas

- **SÍ** — Alteración de marcha, hiperreflexia, signo de Hoffmann o Clonus positivos → 8 **Mielopatía Espondilótica Cervical**
- **NO** — Sin signos de mielopatía → sin hipótesis

todas

2 ¿Hubo un mecanismo de aceleración-desaceleración reciente (latigazo cervical)?

Respuestas

- **SÍ** — ROM cervical significativamente reducido y síntomas de hiperalerta → 5 **Trastornos Asociados a Latigazo Cervical (WAD)**
- **NO** — Sin mecanismo traumático → sin hipótesis

todas

3 ¿El dolor baja por el brazo y es peor que el del cuello?

Respuestas

- **SÍ** — Test de Spurling positivo, ULNT1 positivo o alivio con abducción del hombro → **→ desvío 3b**
- **NO** — Sin irradiación predominante al brazo → sin hipótesis

NO

4 ¿El síntoma principal es cefalea unilateral o dolor en base del cuello/hombro?

Respuestas

- **Cefalea unilateral** — Test de Flexión-Rotación Cervical <30° y síntomas C1-C2 → 4 **Cefalea Cervicogénica**
- **Cefalea primaria** — Criterios de migraña o tensional (el cuello puede contribuir) → sin hipótesis
- **Dolor en hombro/escápula** — Restricción de movilidad de 1ª costilla → 10 **Disfunción de 1ª Costilla (Articulación Costo-Vertebral Superior)**
- **Dolor local/inespecífico** — Sin cefalea ni irradiación dominante → sin hipótesis

continúa en la página siguiente →

4b ¿Hay mareo o inestabilidad como queja principal o acompañante? Descartar antes lo vascular (5 D y 3 N, disección).

todas

5 ¿Cuál es la función más alterada en este paciente?

todas

6 ¿Dónde está la disfunción? En todos: tarea provocadora, postura, control motor y región torácica.

Respuestas

- **MAREO CERVICOGÉNICO** — Aturdimiento o inestabilidad ligados al cuello + error de reposición >4–5° → 13 Mareo Cervicogénico
- **VESTIBULAR** — Vértigo rotatorio; tras golpe en cabeza o cuello, pensar también en conmoción → sin hipótesis
- **NO** — Sin mareo → sin hipótesis

Respuestas

- **Déficit de Movilidad** — ROM activo reducido y PAIVMs C0-C3 hipomóviles → 1 Disfunción Articular Cervical
- **Déficit de Coordinación** — CCFT alterado o test de reposicionamiento alterado → 2 Disfunción Neuromuscular Cervical
- **Déficit de Fuerza** — Reducción de fuerza de flexión o extensión cervical → 6 Debilidad Muscular Cérvico-Escapular
- **Déficit de Resistencia** — Fatiga muscular en actividades funcionales → 11 Fatiga Muscular Cérvico-Escapular
- **Déficit Postural** — Lordosis reducida o cabeza adelantada evidente → 9 Disfunción Postural Cérvico-Torácica
- **Dolor crónico inespecífico sin patrón dominante claro** → 7 Dolor Mecánico Cervical Inespecífico Crónico

Respuestas

- **CRANEOCERVICAL (C1–2)** — Dolor en los primeros grados de rotación, restricción precoz, FRT <30° o 10° de asimetría → 14 Dolor Cervical Idiopático
- **FACETA CERVICAL** — Extensión-rotación positiva + disfunción segmentaria palpable y dolorosa → 14 Dolor Cervical Idiopático
- **CERVICAL BAJA Y CERVICOTORÁCICA** — Giro libre al inicio pero excursión final limitada → 14 Dolor Cervical Idiopático
- **NINGUNO** — No es idiopático o no se localiza → sin hipótesis

Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor cervical inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de cervical.

Generado desde los datos de la app el 29/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0